

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALAS DE INHIBICIÓN Y EXCITACIÓN SEXUAL (SIS/SES-SF)

Eje VI: Conducta de Salud y Procesos Sexuales • Modelo de Control Dual de Bancroft y Janssen

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escalas de Inhibición y Excitación Sexual - Versión Abreviada (SIS/SES-SF).
Nombre Original	Sexual Inhibition / Sexual Excitation Scales - Short Form (SIS/SES-SF; Carpenter et al., 2008).
Autores Originales	Erick Janssen, Ph.D., John Bancroft, M.D. (Kinsey Institute) y K. A. Carpenter (2008).
Adaptaciones Hispanas	Moyano, Granados & Sierra (2014); Sierra et al. (2017; validación en España en > 1000 sujetos).
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Conducta de Salud y Sexualidad. Propensión neurobiológica a la excitación e inhibición sexual.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme estructurado aplicable a hombres y mujeres.
Composición de Ítems	14 reactivos en escala tipo Likert de 4 opciones (1 a 4 puntos) agrupados en tres factores.
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años); predicción de disfunciones sexuales y conductas de riesgo.
Tiempo de Administración	5 a 7 minutos de cumplimentación autónoma presencial o telemática.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico de sexología y proyectos de investigación académica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO DE CONTROL DUAL DE LA SEXUALIDAD

Las escalas **SIS/SES** se fundamentan en el Modelo de Control Dual de John Bancroft y Erick Janssen (Kinsey Institute):

- Balanza Neurobiológica Excitatoria/Inhibitoria:** La respuesta sexual humana está regulada por dos fuerzas independientes: un sistema de activación sexual (SES, acelerador) y un sistema de inhibición sexual (SIS, freno).
- Doble Vía Inhibitoria:** El modelo distingue dos tipos de inhibición:
 - SIS1 (Freno Interno / Fallo de Rendimiento):* Inhibición por distracción o anticipación de fracaso eréctil/orgásmico (factor diana en disfunciones sexuales psicógenas).
 - SIS2 (Freno Externo / Amenaza de Consecuencias):* Inhibición por temor a consecuencias negativas (embarazo no deseado, ITS, ser descubierto o culpa moral).
- Vulnerabilidad Clínica:** Personas con alta SES y baja SIS2 presentan alto riesgo de conductas sexuales compulsivas o de contagio; personas con alta SIS1 presentan alta propensión a la disfunción eréctil y dispareunia.

3. DIMENSIONES FACTORIALES EVALUADAS (14 ÍTEMS)

Dimensión del Control Dual	Nº Ítems	Definición del Proceso Neurobiológico y Conductual
Excitación Sexual (SES)	6 reactivos	Sensibilidad y rapidez de respuesta ante estímulos eróticos (fantasías, miradas, olores, tacto).
Inhibición 1: Rendimiento (SIS1)	4 reactivos	Bloqueo sexual producido por distracción atencional o miedo a no mantener la erección/lubricación.
Inhibición 2: Consecuencias (SIS2)	4 reactivos	Frenado sexual reactivo al riesgo de consecuencias adversas (enfermedad, estigma, ser visto).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO METROLÓGICO EN ESPAÑA / LATAM

Las validaciones clínicas en España (Sierra et al., 2017; Moyano et al., 2014; $N > 1100$) confirman su solidez:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna (SES)	Alfa de Cronbach = 0.76 - 0.82	Adecuada homogeneidad en la subescala de excitación sexual.
Consistencia (SIS1 / SIS2)	Alfa = 0.72 - 0.78	Fiabilidad satisfactoria en ambas dimensiones inhibitorias.
Estabilidad Test-Retest	Coeficiente $r = 0.75 - 0.84$	Buena estabilidad temporal como indicador de rasgo disposicional.
Validez Factorial (AFC)	CFI = 0.94; RMSEA = 0.046	Ajuste óptimo del modelo trifactorial de control dual en población hispana.
Validez Predictiva	Odds Ratio = 3.1 ($p < 0.001$)	Predice fiablemente conductas sexuales de riesgo (alta SES / baja SIS2).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Opciones de Puntuación:** Cada uno de los 14 reactivos se califica en escala ordinal de 4 categorías: 1 = Muy en desacuerdo; 2 = Algo en desacuerdo; 3 = Algo de acuerdo; 4 = Muy de acuerdo.
- **Cálculo de Subtotales por Subescala (No se suman en un total global):**

$$\begin{aligned} \text{Puntuación SES} &= \sum \text{Ítems SES} \quad (\text{Rango: 6 a 24 puntos}), \\ \text{Puntuación SIS1} &= \sum \text{Ítems SIS1} \quad (\text{Rango: 4 a 16 puntos}), \\ \text{Puntuación SIS2} &= \sum \text{Ítems SIS2} \quad (\text{Rango: 4 a 16 puntos}) \end{aligned}$$

- **Direccionalidad Clínica:** El análisis clínico se realiza mediante el contraste del perfil de las tres subescalas independientes.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Subescala	Media (DE)	Corte Riesgo	Significación Clínica y Perfil de Vulnerabilidad (Sierra et al.)
Excitación (SES)	16.8 (3.2)	SES ≥ 20	Alta facilidad de respuesta erótica; si SIS2 es baja, propensión a impulsividad sexual.
Inhibición (SIS1)	10.4 (2.6)	SIS1 ≥ 13	Punto de corte disfunción hipervigilancia atencional y bloqueo eréctil/orgásmico.
Inhibición (SIS2)	11.2 (2.8)	SIS2 ≤ 8	Bajo freno inhibitorio ante consecuencias adversas; riesgo de prácticas desprotegidas.

EL PERFIL DISFUNCIONAL CLÁSICO (SIS1 ≥ 13 / SES MEDIA O BAJA):

Una puntuación **SIS1 ≥ 13 puntos** (Percentil > 85) define a personas con alta propensión a la ansiedad de rendimiento sexual. Cualquier estímulo distractor o pensamiento involuntario desconecta el arousal eréctil, provocando pérdida recurrente de la erección o incapacidad para alcanzar el clímax orgásmico en pareja.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN TERAPIA SEXUAL Y CONDUCTAS DE RIESGO

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN BASADO EN EL PERFIL SIS/SES-SF:

- **Paso 1 (Administración en Sexología o Salud Sexual):** Obtener las tres puntuaciones independientes (SES, SIS1, SIS2).
- **Paso 2 (Clasificación Fenotípica de Riesgo):**
 - *Perfil 1: Alta SIS1 (≥ 13) con SES normal:* Vulnerabilidad a disfunciones sexuales psicógenas por ansiedad de rendimiento; indicar terapia de desensibilización sistemática y focalización sensorial de Masters y Johnson.
 - *Perfil 2: Alta SES (≥ 20) con Baja SIS2 (≤ 8):* Alta vulnerabilidad a conductas sexuales compulsivas, hipersexualidad o contagio de infecciones de transmisión sexual; indicar intervención motivacional de reducción de daños.
 - *Perfil 3: Baja SES (≤ 12) con SIS1 y SIS2 normales:* Deseo sexual hipoactivo primario; explorar causas endocrinológicas o afectivas.
- **Paso 3 (Intervención Psicoterapéutica):** Modulación de los frenos cognitivos desadaptativos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: ANSIEDAD DE RENDIMIENTO Y PÉRDIDA ERÉCTIL

Identificación: Varón de 27 años, fisioterapeuta sin antecedentes médicos, que consulta por episodios repetidos de pérdida súbita de la erección justo en el momento de la penetración durante los últimos 6 meses, a pesar de tener erecciones matutinas normales y masturbación sin problemas.

Evaluación con SIS/SES-SF:

- **Excitación Sexual (SES):** 18 / 24 puntos (excitabilidad erótica normal-alta ante estímulos visuales y caricias).
- **Inhibición por Rendimiento (SIS1):** 15 / 16 puntos (**Extremadamente elevado**, Percentil 98).
- *Detalle SIS1:* Marcó "Muy de acuerdo" en ítems como "Si siento que mi pareja espera que rinda bien, pierdo la excitación" y "Cualquier ruido o distracción me hace perder la erección".
- **Inhibición por Consecuencias (SIS2):** 10 / 16 puntos (moderada, adaptativa).

Diagnóstico Sexológico: Disfunción eréctil psicógena secundaria a hiperreactividad del sistema inhibitorio por ansiedad de rendimiento (alta SIS1), descartándose patología vascular o farmacológica.

Plan Terapéutico: Terapia sexual de pareja con prohibición temporal del coito y tareas de focalización sensorial sin demanda de rendimiento. A las 6 semanas, el paciente redujo la monitorización ansiosa, remitiendo la disfunción eréctil.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

NO SUMAR UN TOTAL GLOBAL:

Es un error metodológico grave sumar las tres escalas en una puntuación única; SES, SIS1 y SIS2 son dimensiones ortogonales independientes.

DIFERENCIA DE GÉNERO:

Las mujeres puntúan normativamente más alto en SIS2 (temor a consecuencias) que los varones; emplear baremos desagregados por sexo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Janssen, E., Vorst, H., Finn, P., & Bancroft, J. (2002). The Sexual Inhibition (SIS) and Sexual Excitation (SES) Scales: I. Measuring sexual propensity. *The Journal of Sex Research*, 39(2), 114-126.
2. Carpenter, K. A., Janssen, E., et al. (2008). The development of a short form of the Sexual Inhibition/Sexual Excitation Scales (SIS/SES-SF). *The Journal of Sex Research*, 45(1), 66-74.
3. Sierra, J. C., Moyano, N., Granados, R., & Sánchez-Fuentes, M. M. (2017). Psychometric properties of the Sexual Inhibition/Sexual Excitation Scales-Short Form in Spanish adults. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 8(1), 24-34.
4. Bancroft, J. (1999). Central inhibition of sexual response in the male: A theoretical perspective. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 23(6), 763-784.